# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66418
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-06-23 12:51:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : NELLY DEL CARMEN OCARES ROMERO | | | RUN | : 7.336.900-2 |
| F.Nac | : 12-08-1945 | Edad | : 77 AÑOS, 10 MESES | Género | : Femenino |
| Dirección | : | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : SIN INFORMACION | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 22-06-2023 | Fecha Egreso | : 2023-06-23 12:51:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : DOMICILIO | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Sd motor BC izq disarmónico (predominio crural), obs componente funcional
-Obs trombofilia
-Obs vasculitis SNC
-FA paroxística
-Tumor ureteral distal derecho y HUN severa secundaria

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Se evalúa paciente conocida. Refiere haber presentado el 21/6/23, aprox a las 09.00AM, mientras comía, una paresia súbita de EII, no asociada a otros síntomas. TC cerebro de ingreso y otro tomado aprox 12h despues sin lesiones agudas. PANTC impresiona HUN derecha severa, vesicula biliar dilatada con calculo de aprox 17 mm, via biliar visible impresiona dilatada. Informe describe presencia de tumor a nivel de ureter distal derecho. Al anamnesis muy dudosa adherencia a antihipertensivos y anticoagulante, paciente refiere no querer usar más medicamentos.
Se mantiene en BEG, HDN con HTA leve a moderada, eupneica, se alimenta sola sin dificultad, no refiere otras molestias, RS al monitor, afebril, sin fluctuaciones respecto a ingreso.
Exs lab ingreso destaca INR>3.
Al ex neurologico destaca: fuerza ESI M4, EII M0-1; ex mental, PC y sensibilidad sin cambios respecto a última evaluacion. Es destacable que al estimulo tactil no doloroso en planta de pie izquierdo moviliza toda la EII venciendo gravedad, no pudiendo realizarlo cuando se le ordena, según la propia paciente.
Impresiona componente funcional importante asociado.
En vista que existe una probabilidad de trombofilia (por eventos isquémicos arteriales y venosos, exs solicitados la semana anterior), se decide iniciar enoxaparina SC a dosis plenas, sin embargo, es llamativo que presente aparentes episodios cerebrovasculares isquémicos agudos con el uso de dabigatran, cuando no los presentó durante todo el largo periodo en que no usó acenocumarol, manteniendo siempre un INR 1 en controles de poliTACO (la propia paciente reconoció no haber tomado acenocumarol).

Evolución
Paciente BEG, HDN estable con HTA leve, afebril, eupneica, tolera bien alimentación VO, estable en déficit neurológico descrito previamente. Se solicita uroTC previo a evalución por Urología (ambulatorio).
En exs solicitados previamente destaca presencia de ANCA-C(+).
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, IC HODOM para KNTM, mantener anticoagulación sólo con enoxaparina 60 mg c/12h, iniciar prednisona por sospecha de vasculitis SNC y reiniciar tto de patologías crónicas.

## PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-HODOM para KNTM
-Control en policlínico de Neurología en 10-12 días
-IC Urología
-IC Medicina Interna

-Pendiente RM cerebro (solicitada en hospitalizacion anterior), se añadirá solicitud de estudio de pared de vasos para descarte de vasculitis

## INDICACIONES AL ALTA

1. -Enoxaparina 60 mg c/12 SC
2. -Prednisona (20 mg) 2-1
3. -Omeprazol 20 mg/d
4. -Calcio 1/d
5. -Cotrimoxazol (800/160) 1 comp Lu-Mi-Vi
6. -AAS 100 mg/d
7. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
8. -Carvedilol (25 mg) 1/2 comp c/12h
9. -Losartan 50 mg c/12h
10. -Hidroclorotiazida (50 mg) 1/2 comp al día

## EXÁMENES Y RESULTADOS

20/6/23
-Anticoagulante lúpico pendiente
-Anti B2 GP pendiente
-Anti cardiolipina IgM/IgG 2.1/0.8 (<10)
-Fc II (mutacion) pendiente
-Fc V (mutacion) pendiente
-Prot C pendiente
-Prot S pendiente
-Antitrombina III 83.7% (79.4-112)
-ANA(-)
-C3 95.8 (70-180)
-C4 21.1 (16-45)
-ANCA-C(+)
-AntiDNA(-)
-Perfil ENA(-)
-Homocisteina 12.1 (5-15)

## OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RII 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurologico:
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N, gnosias N
-PC: CV impresiona N, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve (secuelar?), disartria(-), sensibilidad facial N, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: BC derecho M5, ESI M4, EII M3 (con estimulo doloroso), RCP flexor bilateral
-Sensitivo: impresiona conservado
-Cerebelo: n/e en EII, impresiona conservado en resto EE y proporcional a paresia en ESI
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO